

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU)



ROTINA CLÍNICA

Material de apoio

RESUMO

- **Epidemiologia:**

A ITU é considerada a infecção bacteriana mais comum.

É 6 vezes mais frequente em mulheres do que em homens.

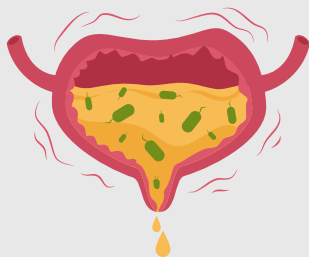
- **Fisiopatologia:**

Colonização + Ascensão da flora bacteriana fecal.

- **Microbiologia:**

Escherichia coli (75-95%).

Outros: *Enterococcus* spp, *Klebsiella*, *Proteus* e *Enterobacter*.



RESUMO

- **Sinais/Sintomas:**

Locais: Disúria, polaciúria, urgência urinária, dor suprapúbica, presença de piúria, hematúria.

Sistêmicos: Febre, queda do estado geral, sinal de Giordano positivo, dor costovertebral, náuseas e vômitos.

- **Classificação anatômica:**

Cistite (ITU baixa): Infecção limitada à topografia da bexiga. Sinais/Sintomas localizados. O diagnóstico é clínico e, em geral, não é necessário solicitar exames complementares (há exceções*).

Pielonefrite (ITU alta): Infecção atinge a topografia renal. Sinais/Sintomas locais e sistêmicos. O diagnóstico é clínico, mas deve-se solicitar exames complementares.



DETALHAMENTO

- **Detalhes sobre Pielonefrite:**

Febre está presente em cerca de 90% dos casos.

Triade “clássica”: Febre, dor costovertebral/dor em flancos e náuseas/vômitos.

Pode ser pouco sintomática, em determinados grupos, como as gestantes.

- **Indicações de internação:**

Pacientes com ITU não complicada, incluindo pielonefrite, em geral, **não** necessitam de internação hospitalar.

Pacientes com quadro séptico, indivíduos incapazes de tomar a medicação por questões clínicas e/ou sociais, pacientes com pielonefrite obstrutiva e pielonefrite complicada **devem** ser internados.



DETALHAMENTO

- **Pielonefrite complicada:** Pacientes transplantados renais, presença de anormalidades anatômicas urinárias, insuficiência renal aguda ou crônica, imunocomprometidos e infecções nosocomiais (Pielonefrite Aguda - Mariya Belyayeva; Stephen W. Leslie; Jordan M. Jeong).



ABORDAGEM

- **Solicitação de exames:**

NÃO SOLICITAR: Mulheres sem alteração estrutural do trato urinário com sintomas sugestivos de cistite (a maioria dos casos que você irá atender).

SOLICITAR: Em todos os outros pacientes.

- **Sobre os exames:**

EAS/Sumário de Urina/Urinalise: Piúria (achado praticamente universal), Nitritos (evidência de crescimento bacteriano), Hematúria, Cilindros leucocitários (presentes na pielonefrite).

Urocultura: Padrão ouro.

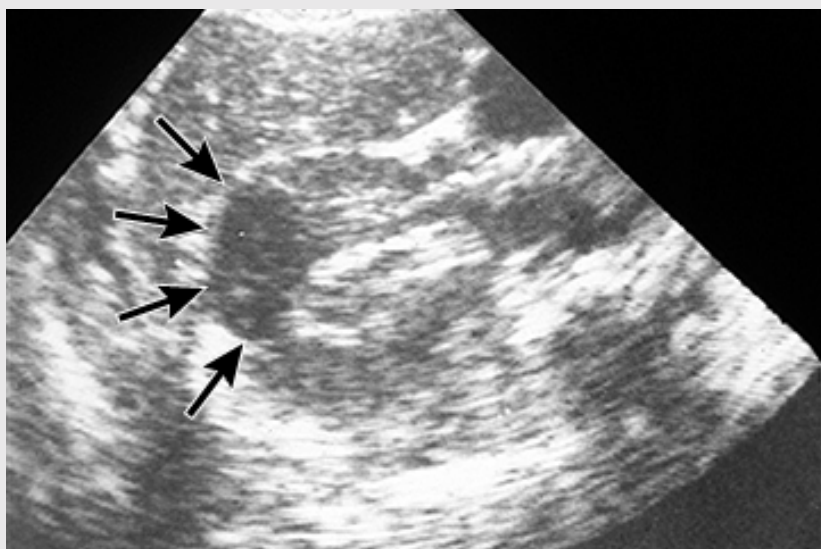
Demais exames: Hemograma completo, Proteína C reativa (PCR), Sódio e Potássio, Ureia e Creatinina.



ABORDAGEM

- **Exames de imagem:**

Em geral, indicado nos casos em que a febre não melhora após 72 horas de tratamento antimicrobiano ou em caso de suspeita de complicações associadas (por exemplo: abscesso).



USG evidenciando rim com massa hipoecóica indicativa de pielonefrite ou abscesso precoce. (setas).



ABORDAGEM



TC evidenciando pielonefrite aguda com presença de região hipodensa no rim direito.



Pielonefrite aguda bilateral com presença de estrias hipodensas triangulares (nefrogramas estriados).



ROTINA CLÍNICA

RESUMO

Cistite

Infecção limitada a topografia da **bexiga**.

Sinais/Sintomas localizados.

Diagnóstico clínico, **sem necessidade** de exames complementares*.

Pielonefrite

Infecção atinge topografia **renal**.

Sinais/Sintomas locais e sistêmicos.

Diagnóstico clínico, porém **necessário solicitar exames complementares**.



ROTINA CLÍNICA

TRATAMENTO

- **Racional:**

Paciente com sinais vitais estáveis e sem achados de gravidade/complicação pode receber alta para realização de tratamento domiciliar com antibioticoterapia oral.

(Protótipo: cistite na mulher jovem, sem comorbidades).

Pacientes com alteração de sinais vitais e/ou achados de gravidade (transplantado, neutropênico, anormalidades urogenitais, homens*, sintomas sistêmicos intensos, comorbidades graves) devem ser internados para início do tratamento com antibioticoterapia parenteral.

Demais detalhes do tratamento estão apresentados nos modelos de prescrição.



ROTINA CLÍNICA

PROFILAXIA

- **ITU de repetição/recorrente:**

Definição: 2 ou mais infecções em 6 meses, OU 3 ou mais infecções em 1 ano (UpToDate). O ideal é manter seguimento ambulatorial e complementar propedêutica (avaliar diagnósticos diferenciais).

No guia de prescrição, você encontrará mais detalhes sobre como prescrever a profilaxia para pacientes com cistite de repetição.



REFERÊNCIAS

- Infecção do trato urinário - Medicina de Emergência USP 17ª Edição.
- Acute complicated urinary tract infection (including pyelonephritis) in adults - UpToDate.
- Asymptomatic bacteriuria in adults - UpToDate.
- Recurrent simple cystitis in women - UpToDate.

